جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : نجلاء محمد فاوى محمود
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** الوراق **العنوان :** الوراق
رقم البطاقة : 28112192101946 **رقم التليفون :** 01000929994 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 23-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 19-12-1981 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: نجلاء محمد فاوى محمود
National ID: 28112192101946

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



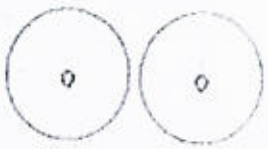


National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Population Program for Maternal Health
Ministry of Health and Population

MDT form

A-Patient ID:
1- Name : نجلاء محمد فاروق محمود
Sex: Female
3- Medical number: 83176763
Old Med :
2-ID number: 28112192101946
Patient Age : 42 Y
4006-2023



Family history		Phone	01009299994	BMI		REASON OF MDT	
marital status		NRS Score		GROUP		Date of MDT	27/04/2024
Co morbidity	dm,htn	Menopausal status		Initial STAGE			

Clinical data

Breast Imaging :
30/11/2023:
1.4*1.3CM Non specific LN
New son mamo requested

Mets Workup :
Non contrast
CT CAP : free

BX	ER	PR	Her 2 Neu	SISH	Ki67
ILC	8/8	8/8	0		5

T	N	M
3	0	0

Sonomammography

PATIENT HISTORY
pt received 3 months neoadj nolvadex & no abovious response
us:stable & received NAC

MDT OUTCOME & PLAN

for NACT AC x4 followed by taxol x 12 weeks
clips insertion ACES ON
then discuss surgery

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY		RADIOLOGY	
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Name: نجلاء محمد فاوي محمود	
MR. : 2696	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالتها

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها

The patient is a 44-year-old female diagnosed with stage IIIA (T3N0M0) invasive ductal carcinoma, grade II, estrogen receptor 8/8, progesterone receptor 8/8, HER2 negative, Ki-67 75%. Neoadjuvant chemotherapy consisted of 4 cycles of AC (doxorubicin/cyclophosphamide) followed by 12 cycles of taxol. She underwent lumpectomy with sentinel lymph node dissection in November 2024, with pathology showing 0/6 positive nodes. Post-surgery, the patient received adjuvant radiotherapy to the breast and axilla (PORT AI) starting December 2024. She has been on Femara, calcium, and zoledronic acid 4 mg monthly for bone protection. A scheduled follow-up chest X-ray and full laboratory workup were due on 21 April 2026.

A chest X-ray performed on 22 April 2026 was normal with no evidence of pulmonary metastasis. The patient's breast ultrasound was not performed on that day due to the scheduled zoledronic acid infusion. Laboratory studies were within normal limits. The patient remains on her current adjuvant therapy regimen and is scheduled for routine surveillance imaging and laboratory monitoring.

تحريرا في ,

التاريخ :	20-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : ايه مدحت بدوي محمد

يعتمد ,

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
المدينة للمراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
إدارة الأشعة

Total DLP (mGy.cm)

Patient Name: Naglaa Mohamed Fawi Mahmoud	Date : 24/12/2023
Exam : C.T. ABDOMEN &PELIVS WITH CONRAST	Age : 42 Year(s)
Medical ID: 4806/2023	Pat. ID: 45476

NON CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

REPORTED CASE OF BREAST CANCER

I Chest:-

- No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Name	:الأستاذه / نجلاء محمد فاروق محمود		
t No.	:28112192101946	Request No.	:1300760[illegible]
No.	:4273/23	Request Date	:30/11/2023
x	:Female	Verification Date	:19/12/2023
ge	:41 Y	Financial Category	: برنامج دكتور السلام - تغطية الدولة
Referreing Doc :		Departr	:Out Patient
		Registered by	:.marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast mass.
Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 30/11/2023, 10:45 am.

Gross Examination:
- Multiple grayish white tissue cores up to 0.8 cm, totally submitted.

Microscopic Examination:
* Histological type: Invasive lobular carcinoma .
* Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis):(3+2+1) Grade II .
* Ductal carcinoma in situ: No.
* Perineural invasion: No.
* Angioinvasion: No.

Diagnosis:
Left breast mass, Tru-cut biopsy:
Invasive lobular carcinoma, Grade II .
For further IHC (E-cadherin,ER, PR, Her2, Ki67).

Dr.Marwa Mahmoud

Dr.Rana Fathy

Verified by :
Dr.Marwa mahmoud

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadeema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الأستاذة / نجلاء محمد قاري محمود	Request No.	: 13007606
Patient No.	: 28112192101946	Request Date	: 30/11/2023
Path No.	: 4273/23	Verification Date	: 19/12/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اوراد دار السلام - تكلفة الدولة
Age	: 41 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Left breast mass.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 30/11/2023, 10:45 am.

Technique:
Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and ematoxylin as counter stain. The sections treated against:
ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Results:
IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
E-Cadherin : Negative .
ER: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (Allred score 8/8).
PR:Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (Allred score 8/8).
Her2: No membrane reaction in the tumor cells (score 0).
Ki67: 5% nuclear reaction of tumor cells.

Diagnosis:
Left breast mass, Tru-cut biopsy:
Invasive lobular carcinoma, Grade II .
IPT:
E-Cadherin : Negative
ER: Positive (score 8/8).
PR: Positive (score 8/8).
Her2: Negative (score 0).
Ki67: Positive in 5% of tumor cells.

Verified by :
Dr.Marwa mahmoud

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr ElQadema - Cairo, Egypt

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

MDT form

A-Patient ID
1- Name : [redacted] Sex : Female
3- Medical number : 53178263
Old Med :
2-ID number
Patient Age : 43 Y
4806-2023

Family history		Phone	0100929994	BMI	
marital status		NRS Store		GROUP	
Co morbidity		Menopausal status		Initial STAGE	

REASON OF MDT :
Date of MDT : 14/11/2024

Clinical data

Breast Imaging :
30/11/2023
L 4*1 3CM Non specific s/N
New sm mamo nodule s/o

Mets Workup :
Non contrast
CT CAP : free

BX	ER	PR	Her 2 Neu	SISH	Ki67
ILC	8/8	8/8	0		5

T	N	M
3	0	0

Sonomammography

PATIENT HISTORY

pt received 3 months neoadj nolvadex & no abovious response
us:stable & received NAC
then NACT 4 AC + 12 weeks taxol with COMPLETE RESPONSE
LARGE AREA OF ARCHITECTURAL DISTORTION CORRESPONDING TO PREVIOUS AREA OF NON MASS
ENHANCEMENT IN THE INITIAL CESM, SMALL BREAST
LT SM+SLN :free margin YPT0 YPN0
LN 0/6.

MDT OUTCOME & PLAN

1- PORT
2- ADJUVANT ZOLADEX AI

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY		RADIOLOGY	
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]